

別記様式1 （第2回）

相談日時	令和5年7月10日（月） 13:00～13:55		
相談者	相談者（本人）	対象者	西田 誠（45歳・男性）
		相談方法	来所
目的	前回（5月15日）来所のフォローアップ。睡眠・疲労・飲酒習慣の経過確認および職場ストレスの状況把握。		
主 訴	「眠れなくて困っている。寝ようとしても頭が冴えてしまう。最近は寝る前に酒を飲まないで眠れなくなってきた。食欲もあまりない」		
状況（客観的）	来所時、前回と比べて表情が疲れており、顔色もやや悪い。体重は前回比約2kg減少。残業時間は月60時間超に増加しているとのこと。飲酒習慣については「毎晩、缶ビール3～4本は飲むようになった。飲まないで眠れない」と述べた（前は週3～4回・1～2本）。睡眠時間は4～5時間程度に減少。食欲不振が2週間以上続いているとの申告。		
状況（主観的）	「部下の仕事のミスをカバーしながら、上からはプレッシャーをかけられて、間に挟まれている感じが続けている。家に帰っても仕事のことが頭から離れない。妻には『顔が変わった』と言われたが、大げさだと思う」と述べた。「酒は飲みすぎとは思うけど、飲まないで何か落ち着かない。ないと不安というか」と付け加えた。笑顔は前回より少なく、話す声に覇気がなかった。		
分析・判断	飲酒量・頻度の急激な増加（入眠目的）、体重減少、食欲不振、睡眠時間の短縮が重なっており、慢性的なストレス過負荷状態にある。「飲まないで不安」という発言はアルコール依存への移行リスクを示唆する。過重労働との複合で、精神的健康が悪化しつつあると判断。産業医への連携および精神科・心療内科受診の検討を勧める時期と見る。		
対応	飲酒量の増加とその背景にあるストレスについて丁寧に確認した。アルコールは一時的な入眠効果があるが睡眠の質を下げること、依存リスクがあることを説明した。産業医への相談を勧め、心療内科・精神科受診も選択肢として提示した。「弱さではなく、体のSOSサイン」と伝え、受診への抵抗感の軽減を図った。次回を6週間後に設定した。		
今後の計画	9月上旬を目安に次回面談を設定。産業医・心療内科受診の有無を確認。飲酒量・睡眠・残業時間の変化を継続把握する。		【支援時期】 令和5年9月 【終了】 医療連携後に再評価